

MEMO STRATEGICO RISERVATO

# Skylabs o Venere

Su cosa puntare dal 1° settembre 2026 — e come eseguirlo

---

Preparato per Luca Martino · Riservato e confidenziale

Basato sui deck “Skylabs AI Evolution” e “Venere”, sul Company Profile 2026 e sui dati 2025

Analisi & decisione · Struttura societaria · Valutazione-soglia · MBO e svincolo · Piano operativo

# Skylabs vs Venere — Le valutazioni per decidere dal 1° settembre 2026

Memo strategico riservato — Luca Martino. Basato sui deck "Skylabs AI Evolution" e "Venere", sul Company Profile 2026 e sui dati reali 2025.

Come leggere questo memo. Non è una decisione presa. In particolare **la scelta principale — mettere il focus su Skylabs o su Venere — resta aperta**: la Parte A è la sua valutazione, non il suo verdetto. Le Parti B e C sono le valutazioni che diventano rilevanti *solo se* propendi per Venere. Dove scrivo "la mia lettura" è un consiglio, non una scelta fatta al posto tuo.

## PARTE A — La scelta di fondo: Skylabs AI Evolution o Venere?

### A1. Le due opzioni sono la stessa mossa su settori opposti

Sono **lo stesso playbook** (buy&build ad arbitraggio di multipli: compri basso, trasformi, esci alto) applicato a **due settori opposti rispetto all'AI**. La tua bravura nel buy&build è la costante; la variabile che decide è **il settore**. Le lenti che seguono servono a valutare quale settore.

### A2. Valutazione — durata dei flussi di cassa contro l'AI

- **Skylabs** consolida l'esatto business che l'AI comprime: services SF/SAP a **5,65% di EBITDA reale 2025** (12% ipotizzato nel piano), ore fatturabili deflazionate dagli agenti; CAGR 88% chiesta in un mercato in decrescita, exit 2029 (vendere l'asset disrupted *più tardi*).
- **Venere** consolida ciò che l'AI non può toccare: atto medico fisico, cash-pay, ricorrenza, vento GLP-1; l'AI è tailwind operativo, non minaccia sul ricavo; entri a inizio ciclo (0 consolidatori, 3-4x).
- *La mia lettura*: **vantaggio netto Venere** — stessa macchina, ma Skylabs controvento, Venere col vento in poppa.

### A2b. Orizzonte e traiettoria del rischio: finestra corta vs runway lungo

Il vero sintetizzatore della scelta non è "quale vale di più", ma **come cambia il valore nel tempo**.

**SAE — vincente, ma solo a 3-5 anni, e sempre più rischioso.** - Finestra **corta e in chiusura**: il piano funziona solo se eseguito e uscito entro ~3-5 anni (2027-30). - Rischio **crescente nel tempo**: ogni anno l'AI comprime di più i ricavi services/reseller, i multipli si derano, i clienti internalizzano, i vendor disintermediano. Oltre i 5 anni SAE è verosimilmente un business in **contrazione strutturale** (a meno di diventare software-company, che non è). - → asset da **harvest ora**, non da tenere: valore massimo oggi, decrescente.

**Venere — più lungo (5-10 anni), e oltre con la robotica.** - Runway **lungo**: il buy-and-build compone per 5-10 anni in un settore in crescita e non-disruptabile. - Rischio **decrescente nel tempo**: più consolidi, più il multiplo si espande (4,5x → 9,5x), più sei #1 nazionale e difendibile. La curva gioca **a tuo favore**. - Il **data play** (dataset → automazione/robotica, vedi Piano) estende l'orizzonte **oltre i 10 anni**: da healthcare-services a med-tech/AI-platform, un secondo atto potenzialmente trasformatore. - **La stessa AI che uccide SAE è il motore di Venere** (moat dati + automazione futura): stesso vento, effetto opposto.

**Sintesi**: non è "SAE o Venere", è "**SAE adesso — finché vale — per finanziare Venere, che vale sempre di più**". Harvest la finestra corta di SAE (2027) e redeploy nel compounding lungo di Venere.

### A3. Valutazione — competenza scarsa vs commodity

- In **Skylabs** la tua competenza tech è il tuo mestiere, ma **abbondante e deflazionata**.

- In **Venere** è **scarsa e difendibile**: nessuno studio ha gestionale proprietario + dataset di outcome. Il tuo DNA AI diventa il **moat**.
- *La mia lettura*: **vantaggio Venere**. Il gap che ti manca (retail/cliniche) è il più assumibile.

---

## A4. Valutazione — dimensione × traiettoria della consulenza

La consulenza **si biforca**: perde chi vende ore, vince chi vende esiti/prodotto. **Dati reali 2025: €8,2M ricavi, €465k EBITDA (5,65%)**; target 2026 €12M di cui €3M licenze — **ma le licenze sono rivendita SF/SAP (reseller), non prodotto**: pass-through a basso valore, in disintermediazione (Agentforce, Joule). Sei **piccolo, a margine sottile, nella nicchia deflazionata**. E la scala lavora al contrario: in AI resti un pesce piccolo tra le balene; in estetica a 20-30 cliniche sei **#1 nazionale** (multiplo che si espande, 4,5x → 9,5x). - *La mia lettura*: rafforza Venere, e dice che **il valore relativo di Skylabs è massimo ora** → se scegli Venere, monetizza Skylabs presto.

---

## A5. Valutazione — investitori e fiducia

Temi che gli investitori non si fidino su un mercato nuovo. Gestibile: ti presenti come *l'operatore che ha exitato un gruppo AI e applica la stessa disciplina + un moat tech a un mercato vergine*, con Cammalleri per la credibilità clinica e una **tranche 1 da 4-5M** che deriska prima dei 12M. Mitigante più forte: coinvolgere come **advisor i fondatori di Hippocrates Holding** (il roll-up delle farmacie "La Farmacia"), che hanno già costruito un **buy-and-build healthcare-retail regolato in Italia** — la loro presenza chiude il tuo gap di credibilità di settore agli occhi dei family office (dettaglio e cautele nel Piano). - *La mia lettura*: pari sulla facilità di raccolta, **Venere sulla solidità della tesi**.

---

## A6. Valutazione — ritorno per te (NON è alla pari: B è superiore)

Correggo una semplificazione: confrontare i *casi di successo* (€26,5M vs €15-30M) fa sembrare i ritorni simili, ma è fuorviante per due ragioni — il successo di A è molto meno probabile, e B ha **due** fonti di valore.

**A — tenere Skylabs**: i €26,5M sono il successo pieno, che richiede **88% CAGR + 3 acquisizioni + 10x** in un settore disrupted e con multipli in compressione (da €465k a €10,3M di EBITDA in 4 anni): **bassa probabilità**. Risk-adjusted, la tua quota vale **~€5M (PV)**. Ed è **una sola scommessa**, senza il paracadute della vendita.

**B — Venere + vendita Skylabs**: due fonti diversificate: - **Vendita Skylabs**:  $\sim 48\% \times \text{€13-30M} \approx \text{€6-14M}$ , a breve e relativamente de-riskato (trade sale). - **Quota Venere**:  $\sim 15\%$  (pre-ratchet) di un exit €90-125M  $\approx \text{€13-19M}$  base, di più col **ratchet**, su 5-6 anni, in un **settore in crescita**, con **playbook provato due volte** e le protezioni strutturali (vesting, cliff, buy&build che compone). - **Totale B**  $\approx \text{€20-35M}+$ , su due asset con rischio/tempi diversi. Anche risk-adjusting Venere, B vale **~€15-25M** contro i ~€5M di A.

- *La mia lettura*: **hai ragione, non è alla pari**. Su base risk-adjusted B è nettamente superiore ad A (ordine di 3-4x), perché (i) il successo di A è molto meno probabile, (ii) B ha *anche* la monetizzazione di Skylabs, (iii) settore e struttura di B rendono il suo successo più raggiungibile. Il ritorno **rafforza** la propensione verso Venere.

---

## A7. Steelman dell'opzione Skylabs (perché potresti restare)

- È un *bird-in-the-hand* (100+ persone, 60+ clienti blue-chip, ISO, cassa).
- La vision "global reference for AI" ha un **tetto teorico più alto** — **ma appartiene a una software company, non al roll-up di ore del deck** (Product ~2% dei ricavi; licenze reseller). Se il prodotto fosse il vero sogno, la mossa è mettere tutto su Universe, non comprare 3 consulenze.
- Cambiare settore = imparare un ambito medico regolato da zero, con rischio reputazionale a coda.

## A8. Valutazione — le due decisioni sono separabili

- **Monetizzare Skylabs** (confidenza alta): regge da sola, quasi a prescindere da Venere.
- **Redeployare in Venere** (confidenza media, testabile a basso costo): la struttura a fasi (4-5M prima dei 12M) ti fa provare il potenziale con rischio limitato.
- *La mia lettura*: non "vendi perché Venere è fantastica", ma **"vendi perché è il momento giusto per Skylabs"**, e usi i proventi per una scommessa a rischio limitato.

### → Raccomandazione sulla scelta di fondo

| Lente                                                              | Vince                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Durata cash flow vs AI · Competenza · Ciclo · Tesi per investitori | <b>Venere</b>                                |
| <b>Ritorno personale risk-adjusted</b>                             | <b>Venere</b> (nettamente: ~€15-25M vs ~€5M) |
| Bird-in-hand / minor rischio esecutivo                             | Skylabs                                      |

**La mia raccomandazione (non una decisione): propendere per Venere, monetizzando Skylabs.** Le parti B e C sono le valutazioni che diventano rilevanti se propendi in questa direzione.

## PARTE B — Se propendi per Venere: le valutazioni su Skylabs

### B1. Cosa fare di Skylabs — le quattro opzioni

| Opzione                                                                                                                                                                                                                    | Pro                                                                    | Contro                                                                                           | Quando ha senso                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Vendita piena a strategico</b>                                                                                                                                                                                          | Uscita netta, premio strategico, tutti i fondatori fuori               | Serve svincolo; uno strategico può volerti trattenere                                            | Vuoi uscire per Venere e i soci ti seguono              |
| <b>MBO (ai soci/management)</b>                                                                                                                                                                                            | Founder-friendly, gli insider sono felici che tu esca, tieni minoranza | Servono compratori interni che <i>restino</i> + finanziamento (EBITDA sottile); prezzo più basso | Almeno un socio (Diana) vuole guidare/comprare Skylabs  |
| <b>Build-to-sell (Diana-led)</b>                                                                                                                                                                                           | Exit più grande via roll-up, sfrutta la pipeline                       | Diana deve restare + anni + ti diluisci                                                          | Diana vuole guidarla + round SAE raccogliibili senza te |
| <b>Tenere e scalare (esegui AI Evolution)</b>                                                                                                                                                                              | Tetto più alto se funziona                                             | Resti al timone controvento, exit di asset disrupted, margini sottili                            | Credi che Skylabs diventi una software company          |
| <i>- La mia lettura</i> : se vai su Venere <b>e i soci ti seguono</b> (incluso Diana), l'opzione coerente è la <b>vendita piena a strategico</b> ; l'MBO e il build-to-sell hanno senso solo se qualcuno resta a guidarla. |                                                                        |                                                                                                  |                                                         |

### B2. Valutazione — quando e a quanto vendere (la soglia)

Tenere fino al 2029 vale €26,5M solo nel successo pieno (CAGR EBITDA >100% da €465k). Probabilizzato e scontato, il certo-equivalente della tua quota ≈ €4,8M → **EV "indifferente" ~€10M.**

| Prezzo oggi (EV) | ~ multiplo           | Valutazione                                      |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| ≥ €13-16M        | ~1,1-1,3x ricavi '26 | Vendere batte tenere                             |
| €10-13M          | ~1x ricavi           | Zona grigia → tendi a vendere                    |
| < €10M           | <0,8x ricavi         | Non svendere per i soldi (solo per focus/Venere) |

Sui fondamentali un finanziario paga €5-10M; il ponte verso €13-30M lo costruiscono **logo blue-chip + storia AI + pipeline + Partner Program** (premio strategico).

### B3. Valutazione — a chi vendere

| Compratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cosa paga                                                           | Nota                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Strategico ecosistema SF/SAP</b> (es. <b>Cegeka, Bip</b> )                                                                                                                                                                                                                                                     | Capability AI + scala certificata + logo + pipeline → <b>premio</b> | Il più adatto se esci; può volerti trattenere → serve svincolo |
| <b>Finanziario puro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EBITDA (basso)                                                      | Prezzo più basso; vuole management che resta                   |
| <b>Interno (MBO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Founder-friendly                                                    | Solo se un socio resta a guidarla                              |
| - <i>Candidati concreti</i> : <b>Cegeka Italia</b> (gruppo IT belga familiare, capitale paziente, fit strategico) e <b>Bip</b> (PE-backed CVC, logica piattaforma/multiplo, ama una pipeline pronta). Falli <b>competere</b> in un processo (+ 1-2 alternativi: Reply, Lutech, Engineering, NTT Data, Accenture). |                                                                     |                                                                |

### B4. Valutazione — come sfruttare pipeline e Partner Program nell'exit

- **Pipeline** (Sidea ott'26, Advant mag'27, Lobra "forse" lug'27): integrandone almeno Sidea/Advant porti sul mercato un gruppo da ~€15-20M invece di €8M, e presenti Lobra come deal che il compratore eredita → prezzo più alto.
- **Partner Program** (interni entro 31/12/26 + 4 Senior Partner esterni): de-personalizza, porta origination indipendente, blocca la retention (vesting + lock-up). Con i **leader delle acquisizioni** (CEO Lobra, commerciale Sidea, CEO Advant) forma la **panchina** che dà al compratore continuità.
- Da valutare: **selezione non nomina** (finestra di prova prima di dare ruoli chiave), e **ancorare la continuità sul deal certo (Sidea)**, non su quello incerto (Lobra).

### B5. Valutazione — il vincolo key-man e come scioglierlo

Una società di servizi vale finché ci sei tu. Ma sei **quasi già svincolato**: clienti già distribuiti al business; l'unica dipendenza residua è **Diana**, risolvibile con un **GM** al suo posto. Con GM + panchina, uno strategico accetta l'uscita di tutti i fondatori (o un Chairman-light breve). "*Uscire*" = *off-operations + earn-out minimizzato + più cash upfront*.

## PARTE C — Le valutazioni su Venere

### C1. Valutazione — chi portare in Venere

Venere ha bisogno di **clinico (Cammalleri) + retail-ops (COO da assumere) + un owner software focalizzato** — non di un secondo team AI-consulting. Da valutare persona per persona (desiderio e fit): - **Diana (Salvo)** — **operatore esperto, tuo #2**

**provato, e owner di uno dei due motori primari: il moat AI/dati.** Poiché il dataset si instrumenta dalla clinica #1 e il decision-support entra già in Fase 2 (non è un'optionality di Fase 3), il suo ruolo è **strategico, non di supporto** → la mia lettura sale a ~22% (range 20-24%, fino a ~25% se co-leader strategico). I punti in più escono da Luca, non dagli operatori. Cautele: (a) incassa **anche** la vendita di Skylabs; (b) entra **post-closing** (~H2'27), **sincronizzato con la prima acquisizione** così struttura la clinica #1 AI-driven da subito (l'architettura dati va impostata Diana-ready fin dall'inizio; lever: accelerare Skylabs a H1'27); (c) **in Fase 1-2 è il dataset/capability a essere front-loaded, non i robot** (l'automazione fisica è lunga). Quindi **lega la parte alta della sua quota a milestone AI/dati** col reverse vesting (dataset costruito, decision-support live, POC automazione). - **Cammalleri (Marcello) — clinical partner part-time: 1 giorno/settimana sul corporate + medico del flagship del gruppo** (dove guadagna i suoi ~€240k → zero cash-burn per la società). Il suo tempo è fondamentale su 5 aree non delegabili: **origination + DD clinica dei target, protocolli/format clinico, reclutamento e retention medici, volto clinico verso investitori/venditori, qualità e reputazione clinica.** Quota ~7% (fondazione 90/10), con **impegno scritto e misurato** (deliverable trimestrali + vesting sui risultati, clausola underperformance) per evitare equity dormiente. Ottima leva: **lanciare la prima clinica brandizzata con lui** come "format lab" e showcase, poi replicare via buy-and-build. Le sue sedi, se confluiscono, valutate separatamente (related-party). *Dettaglio nel Piano.* - **Gli altri soci** — il loro ritorno è la **liquidità della vendita di Skylabs.**

**⚠ Riservatezza (vincolante).** I soci sono **già allineati sulla vendita insieme:** è un asset, non va rimesso in discussione. Ma l'ingresso di **Diana in Venere va tenuto riservato verso gli altri soci fino a dopo il closing** — comunicarlo prima **disgregherebbe il gruppo** e metterebbe a rischio la vendita congiunta. L'arrangement resta tra te e Diana; il suo sviluppo attivo su Venere si manifesta **post-closing** (il che è coerente anche con la pulizia IP: vedi C3).

## C2. Valutazione — struttura, funding e cap table di Venere

**Quando raccogliere** (indipendente da Skylabs, non lo aspetta): Fase 1 **4-5M** soft-circle Set-Nov '26 → closing Q4'26/Q1'27; resto dei 12M ~2028 a metriche provate + debito. Co-invest personale da risorse personali, poi rimpolpato dalla liquidità Skylabs.

**Da chi:** 1 **lead family office anchor** (healthcare/consumer premium, board seat + funzione CFO) → 1-2 **angel di settore** (validazione) → 2-4 altri family office → banche in Fase 2. **Fuori** VC e PE di controllo in Fase 1.

**Cap table founder — proposta (illustrativa, da negoziare):**

*Pre aumento di capitale (founder = 100%):* | Luca | Diana (Salvo) | COO | Marcello (Cammalleri) | ---|---|---|---| **59,4%** | **22%** | **12%** | **6,6%** |

**Regola (nel founders' agreement): il rapporto Luca:Marcello resta 9:1 a ogni stadio** — la quota di Marcello è ancorata a **1/9 di quella di Luca**, e Diana + COO + pool + investitori diluiscono i due **pro-rata**, preservando il 90:10 di fondazione. (Diana alzato da 18 a 22 perché il moat AI/dati è motore primario front-loaded in Fase 1-2; i punti extra escono da Luca, non da Marcello. Con fondazione 85/15 il rapporto ancorato diventa ~5,7:1 e Marcello ~10%.)

*Post raise (€12M per il 60%, pool creato al round):* investitori 60%; Luca ~16,3%, Diana ~6%, COO ~3,3%, Marcello ~1,8% (sempre 9:1 con Luca), pool ~12-13%. Leve: **ratchet** (founder verso 45-50%+ a buon exit), **cash co-invest** (aumenta la tua %), **reverse vesting** su tutti; sedi di Cammalleri valutate separatamente (related-party).

## C3. Valutazione — i nodi legali da chiudere prima di muoverti

1. **Patti parasociali Skylabs** (drag/tag/prelazione/leaver): determinano se e come vendere.
2. **Non-compete** da tutti i fondatori: settore diverso aiuta, servono carve-out per Venere.
3. **Separazione IP** del gestionale: clean-room o licenza periziata, **prima** che Diana tocchi una riga.
4. **Related-party:** ogni scambio Skylabs ↔ Venere a valore di mercato, documentato.
5. **Sequenza e comunicazione ai soci:** win-win, prima del 1° settembre.

Sintesi delle raccomandazioni (tutte da validare, nessuna presa)

| Valutazione          | La mia raccomandazione                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scelta di fondo      | Propendere per <b>Venere</b> , monetizzando Skylabs                                                                 |
| Cosa fare di Skylabs | <b>Vendita piena a strategico</b> (se i soci ti seguono)                                                            |
| A chi                | <b>Cegeka / Bip</b> in processo competitivo                                                                         |
| Quando/prezzo        | Vendere a <b>≥ €13-16M</b> ; puntare €18-30M con pipeline integrata                                                 |
| Diana in Venere      | Sì, come <b>#2 ~22%</b> (moat AI/dati = motore primario), vesting su milestone AI                                   |
| Marcello in Venere   | <b>Clinical partner part-time ~6,6%</b> (mantiene la pratica), rapporto <b>9:1 con Luca</b> preservato a ogni round |
| Funding Venere       | Fase 1 4-5M da family office, da Set '26; non aspetta Skylabs                                                       |

Il *come* eseguire — se scegli questa direzione — è nel Piano operativo allegato.

Appendice — Quanto monetizzi davvero: SAE 2030 vs (Venere 2030 + Skylabs 2027)

*Numeri illustrativi, range non forecast; lordi pre-imposta salvo dove indicato. CGT ~26% (da confermare col fiscalista) applicata a entrambi.*

**Scenario A — resti in SAE, exit 2030** (tua quota diluita ~26%): | Caso | EV gruppo | Tua quota lorda | ---|---|---| | Bull (piano deck: 88% CAGR, €82M ricavi, 10x) | ~€103M | **€26,5M** | | Base (grind realistico: €30-45M ricavi, 6-8x) | €25-40M | **€8-12M** | | Bear (disruption + compressione multipli) | €15-25M | **€4-6,5M** |

→ atteso **~€8-12M**; il €26,5M è il bull a bassa probabilità.

**Scenario B — vendi Skylabs 2027 + Venere:**

**Parte 1 — Skylabs 2027 (tua quota 48%):** | Caso | EV Skylabs | Tua quota lorda | ---|---|---| | Strategico + pipeline (Sidea/Advant) | €18-30M | **€8,6-14,4M** | | Conservativo | €13M | **€6,2M** |

→ base **~€10M**, a breve e relativamente certo.

**Parte 2 — Venere (tua quota ~13-16% diluita, + ratchet):** | Timing | Cliniche / EBITDA | EV | Tua quota lorda | ---|---|---| | **2030 (early, Fase 2)** | 8-12 / €4-6M | €30-48M @7-8x | **€5-8M** | | 2032-33 (maturo, Fase 3) | 20-30 / €12M+ | €90-125M | **€15-25M+** |

**Totali (lordi):** | Scenario | AI 2030 | Se Venere matura (2032-33) | ---|---|---| | **A — SAE 2030** | **€8-12M** (bull €26,5M) | — | | **B — Skylabs '27 + Venere** | **~€15-18M** | **~€25-35M** |

**Netto ~26% CGT:** A ~€6-9M · B@2030 ~€11-13M · B maturo ~€18-26M.

**Conclusione:** B batte A già a un'uscita Venere anticipata al 2030 e domina se lasci maturare Venere. A eguaglia B solo nel suo bull case (€26,5M, bassa probabilità, asset disrupted). B è anche **diversificato e de-riskato** (cassa Skylabs 2027 vicina e certa + upside Venere aggiuntivo). Il vero premio di Venere è ~2032-33: il 2030 ne cattura solo una parte.



# Piano operativo da settembre 2026 — Da Skylabs a Venere

Piano d'azione esecutivo. Riservato. Complemento a `DECISIONE_Skylabs_vs_Venere.md`.

## Cosa esegue questo piano

Questo è il *come* di **una** direzione — la raccomandazione del memo — **non una scelta già presa**: la scelta principale (mettere il focus su **Skylabs o su Venere**) la fai tu, e la valuti nella Parte A del memo. Se propendi per Venere, il piano è questo: - **Focus: Venere.** - **Skylabs: vendita piena, tutti i fondatori insieme, a uno strategico (Cegeka Italia o Bip), entro il 2027.** - **Diana in Venere** (owner del moat software/dati + tuo #2); gli altri soci incassano nella vendita. - **Pipeline (Sidea/Advant/Lobra) + Partner Program** usati per alzare il prezzo e garantire al compratore la continuità che permette a tutti di uscire.

## Principio guida — cosa può correre in parallelo e cosa no

La vendita di Skylabs (2026 → closing H2'27) è retta da **advisor M&A + GM + panchina** (Partner Program e leader delle acquisizioni); non è il tuo focus operativo pieno. Quindi **sì, la porti avanti mentre avvii Venere — ma con una linea netta**:

- **In parallelo, a basso profilo, già da settembre '26**: costituzione **NewCo Venere**, conversazioni con gli **anchor family office**, e **sourcing/avvio delle prime cliniche via Cammalleri + COO**. Non coinvolge Diana e non tocca persone/IP/clienti di Skylabs → non disgrega il gruppo.
- **Solo a/dopo il closing (H2'27)**: ingresso **visibile di Diana** in Venere, **sviluppo attivo del gestionale**, e il tuo passaggio **full-time**. Perché: (a) la riservatezza sul move di Diana tiene insieme il gruppo finché tutti hanno incassato; (b) Diana serve alla **continuità per il compratore** fino al closing; (c) pulizia IP.

**Le due regole invalicabili**: nessuno spostamento di persone/IP/clienti da Skylabs a Venere prima della separazione formale; **Diana resta a Skylabs, visibilmente, fino al closing**. E tieni Venere **a basso profilo** durante il processo di vendita (un fondatore troppo visibilmente "altrove" può raffreddare il compratore).

## FASE 1 — Settembre (Mese 1): fundamenta e allineamento

**Skylabs - Con i soci** (già allineati sulla vendita insieme): allinea su **tempi e processo** di vendita e sull'ingaggio degli advisor. ⚠ **Tieni riservato che Diana ti segue in Venere** — comunicarlo ora disgregherebbe il gruppo e mette a rischio la vendita-insieme: l'arrangement Diana ↔ Venere resta tra te e lui e **si manifesta dopo il closing**. - Ingaggia **avvocato M&A** (audit patti: drag/tag/prelazione/leaver) e **advisor M&A** (pre-valutazione + test d'appetito riservato su Cegeka/Bip). - Avvia lo **svincolo**: insedia/individua il **GM** (de-risk key-man, parte normale della prep di vendita); conferma la distribuzione clienti sul business layer.

**Venere - Costituzione NewCo**; definisci la **separazione IP** del gestionale (clean-room o licenza periziata); **lo sviluppo attivo di Diana su Venere attende il post-closing** (preserva riservatezza verso i soci e pulizia IP). - Brief soft a **2-3 family office anchor**; imposta la **cap table founder** con chi entra, incl. Diana (**riservato verso gli altri soci**). - **Advisory — avvicina i fondatori di Hippocrates Holding (il roll-up delle farmacie "La Farmacia")**: hanno costruito un **buy-and-build in un settore healthcare-retail italiano frammentato e regolato** (le farmacie) — know-how direttamente trasferibile su **consolidamento multi-sede regolato, integrazione, raccolta PE ed exit, e credibilità coi family office** (è il mitigante più forte del rischio "nuovo del settore"). Struttura: **advisory con equity/warrant** (dal pool). ⚠ **NDA e cautela**: operano in consolidamento sanitario adiacente (potenziale futuro competitor o acquirente) → allineali con equity, sii selettivo su cosa condividi del vantaggio proprietario; in positivo possono diventare **co-investitori o una via d'exit**.

🚦 **Gate 1 (fine settembre)**: processo di vendita avviato (l'allineamento dei soci sulla vendita insieme **c'è già**); advisor e legale ingaggiati; NewCo Venere costituita; arrangement Diana ↔ Venere definito **in riservatezza**.



## FASE 2 — Ottobre-Novembre (Mese 2-3): lancio dei processi

**Skylabs** - Chiudi Sidea (ott'26) e insedia i **leader delle acquisizioni** nella panchina. - **Completa il Partner Program** (interni + 4 Senior Partner esterni) **entro il 31/12/26**, con retention lock (vesting + lock-up al change of control). - **Numeri audit-ready + info memo**; apri il **processo competitivo** (Cegeka + Bip + 1-2 alternativi) via advisor.

**Venere** - **Assumi il COO/AD operativo** (retail/sanità multi-sede). - **Pipeline prime cliniche**: 1 cluster (Nord-Ovest o Nord-Est), 8-12 target, **LOI su 2-4**. - **Commitment Fase 1 (4-5M)** dagli anchor; insedia comitato scientifico + advisor regolatorio/fiscale.

 **Gate 2 (fine novembre)**: Partner Program completo e panchina che regge commerciale/delivery senza i fondatori (= go per l'exit in H1'27); commitment Fase 1 Venere + COO + LOI cliniche.

## FASE 3 — Dicembre 2026-H2 2027 (Mese 4-12): closing e transizione

**Skylabs** - **Advant (mag'27)** integrata; processo competitivo → offerte → DD → SPA → **closing entro fine 2027**. Tutti e quattro escono; **incassi**.

**Venere** - **Closing prime 2-4 cliniche**, avvio integrazione a 100 giorni + gestionale. - **Tu e Diana full-time su Venere** dalla chiusura della vendita.

 **Gate 3 (H2 2027)**: Skylabs venduta e incassata + prime cliniche closed + tu full-time su Venere.

## FASE 4 — 2027-28 (Mese 12-24): prova del formato Venere

- KPI: **recurring 10%+, EBITDA/clinica +30%** in 18-24 mesi.
- Se il formato è provato → **chiami il resto dei 12M** (Fase 2 Venere) + linea di debito bancario. Se no, hai rischiato solo 4-5M.

## La governance del tuo tempo (il punto che fa fallire i pivot)

| Fase                     | Skylabs            | Venere      |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| Settembre (impostazione) | 55%                | 45%         |
| Ott-Nov (processi)       | 40%                | 60%         |
| Dic-H1'27 (closing)      | 25% →              | → 75%       |
| Da closing vendita       | <b>0% (uscito)</b> | <b>100%</b> |

Skylabs è retta da **advisor + GM + panchina**: il tuo tempo su di essa scende, non sale. Se non lo fa, non stai facendo il pivot: lo stai rimandando.

### Il tempo di Diana (asimmetrico rispetto al tuo)

Tu puoi tiltare presto sulla prep di Venere (Cammalleri-led, basso profilo). **Diana no: deve restare visibilmente a Skylabs fino al closing** — per la continuità verso il compratore e per la riservatezza sul suo move.

| Fase                      | Diana · Skylabs                                         | Diana · Venere                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Set-Dic '26               | ~ <b>90%</b> (visibile; handover graduale al GM)        | ~0-10% (solo ideazione privata, no build/IP)             |
| H1 '27 (processo vendita) | ~ <b>85%</b> (continuità per il compratore)             | ~15% (design riservato)                                  |
| Closing (H2 '27)          | transizione in uscita (non-compete, handover, earn-out) | ramp-up                                                  |
| Post-closing → 2028       | <b>0% (uscito)</b>                                      | <b>100% — costruisce il gestionale/dataset (il moat)</b> |

Due attenzioni su Diana: - **Porta un segreto mentre resta a Skylabs:** deve performare il suo ruolo e **non disimpegnarsi visibilmente** fino al closing. L'handover al GM va fatto passare come normale prep di vendita, non come "Diana che se ne va". - **Il suo valore in Venere è la piattaforma, non le operations cliniche** (di cui non sa nulla): full-time dal closing a costruire il moat, mentre le prime cliniche (Fase 1) le reggono Cammalleri + COO.

## Skylabs: la vendita a Cegeka Italia o Bip (il dettaglio dell'exit)

### I due compratori

- **Bip** (Business Integration Partners): consulting/transformation di origine italiana, **PE-backed (CVC)**, acquisitivo, in spinta su digital/AI. Ragiona in logica piattaforma/multiplo; ama una **pipeline di roll-up già pronta**.
- **Cegeka**: gruppo IT **belga a controllo familiare** (~€1B ricavi), presente e già acquisitivo in Italia, in costruzione su AI/cloud/SAP. Capitale **paziente**, guidato dal **fit strategico**.

Entrambi vogliono ciò che hai: **capability AI + scala italiana certificata SF/SAP + logo blue-chip + persone**. La differenza di stile (Bip finanziario, Cegeka strategico) è la tua **leva competitiva**.

### La pipeline come acceleratore del prezzo

Non vendere gli €8M standalone: **fai entrare Sidea (ott'26) e Advant (mag'27)**, porti sul mercato un gruppo da **~€15-20M** e presenti **Lobra come il prossimo deal** che il compratore eredita. Vendi *"una piattaforma AI certificata, con roll-up in corso"* → premio strategico.

### Il Partner Program come motore di svincolo e retention

- **Completo entro 31/12/26** (interni + 4 Senior Partner esterni con client book): de-personalizza il business, porta origination indipendente, blocca la retention (equity + vesting + lock-up al change of control).
- I **leader delle acquisizioni** (CEO Lobra, direttore commerciale Sidea, CEO Advant) completano la panchina che dà al compratore la continuità.
- **5 paletti sulla panchina:** (1) selezione non nomina — finestra di prova prima di dare ruoli chiave; (2) squadra, non un uomo solo; (3) ancora la continuità sul deal **certo (Sidea)**, non su quello incerto (Lobra, "forse"); (4) valuta che i profili scalino al livello gruppo; (5) legittimità/equity/mandato chiari + tuo sponsorship.

### Timeline "entro il 2027"

| Periodo       | Mossa                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H2 '26</b> | Svincolo (GM + panchina), numeri audit-ready, info memo, test d'appetito riservato. Chiudi Sidea (ott'26). PP completo entro 31/12 |
| <b>H1 '27</b> | Processo competitivo (Cegeka + Bip + 1-2 alt.), NDA, management presentation, prime offerte. Chiudi Advant (mag'27)                |
| <b>H2 '27</b> | Due diligence, SPA, <b>closing entro fine 2027</b>                                                                                 |

## Le 4 regole per non sbagliarlo

1. **Processo competitivo, mai monotrattativa** (Cegeka + Bip + alt.: Reply, Lutech, Engineering, NTT Data, Accenture). La tensione è il prezzo.
2. **Riservatezza a stadi**: NDA forti, dati sensibili solo a stadi avanzati (Bip è anche un concorrente).
3. **Minimizza il tuo earn-out personale, massimizza cash upfront**: la panchina resta, quindi non devi restare tu.
4. **Allinea i venditori della pipeline**: Sidea/Advant/Lobra reinvestono equity → la loro quota rolla nella struttura del compratore; mettili d'accordo prima.

## Valutazione attesa

Standalone €8-14M; **con Sidea (+Advant) integrate e la panchina in piedi**, un gruppo ~€15-20M con quel profilo può puntare a **€18-30M+** in un processo competitivo Cegeka-vs-Bip. È così che pipeline + Partner Program diventano prezzo.

## Venere: quando raccogliere, da chi, e le quote dei founder

Quando (la raccolta è indipendente da Skylabs e non la aspetta)

| Periodo          | Mossa                                                                                    | Importo         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Set-Nov '26      | Apri conversazioni anchor; <b>soft-circle Fase 1</b> ; chiudi lead anchor + funzione CFO | commitment 4-5M |
| Dic '26 - Q1 '27 | <b>Closing Fase 1</b> ; firma LOI / prime 2-4 cliniche                                   | 4-5M deployati  |
| 2027 (0-18 mesi) | Deploy + <b>prova del formato</b>                                                        | —               |
| ~H2 2028         | A metriche provate, <b>resto dei 12M</b> + debito bancario                               | fino a 12M      |

Il tuo **co-invest personale** lo copri con risorse personali, poi lo rimpolpi con la **liquidità di Skylabs** (fine 2027). **L'istituzionale della Fase 1 Venere non aspetta Skylabs.**

## Da chi (in ordine)

1. **1 lead family office anchor** — affinità healthcare e/o consumer premium, orizzonte 5-6 anni, a suo agio col buy&build; prende board seat ed esprime la funzione CFO. Il suo "sì" trascina il club.
2. **1-2 angel di settore** (ex-operatori medspa/dentale/sanità) — validazione + deal flow; coprono il tuo gap di credibilità di settore.
3. **2-4 altri family office** per completare il club, via la rete dell'anchor.
4. **Banche** (Fase 2+) per la leva sulle acquisizioni.
5. **Small-cap PE / search fund healthcare** — non in Fase 1 (lowballano un asset pre-prova); candidati per le tranche di scala e come compratori all'exit. **Fuori**: VC (modello sbagliato) e PE di controllo in Fase 1.

**Investitore strategico healthcare (es. GKSD / area Gruppo San Donato — relazione calda di Luca)**: doppio taglio. **Pro**: credibilità healthcare che de-riska il "nuovo del settore", tasche profonde (finanzia tutto il roll-up), sinergie (rete medica, governance, regolatorio), possibile via d'exit. **Rischi**: vuole più **controllo/termini**; e soprattutto **cattività strategica** — un gruppo ospedaliero è potenziale competitor e futuro acquirente: se gli dai **ROFR/esclusiva/drag sull'exit** uccidi la tensione competitiva (dove vive il multiplo) e vede il tuo playbook. **Raccomandazione**: usa la relazione (validazione + capitale + contatto d'exit), ma **in parallelo ai family office, non in esclusiva**; forma ideale = **anchor strategico bounded senza diritti che incatenano l'exit**, oppure **lead della Fase 2** (dove tasche e infrastruttura valgono di più e hai già il format provato). In Fase 1 pesa il club di family office (controllo + agilità). Proteggi il playbook in DD (disclosure a stadi, NDA).

## Quanto costa ogni clinica e quanto raccogliere per le prime 2-4

Illustrativo, sulle ipotesi del deck (ricavi 0,8-2,5M, EBITDA 20%+, prezzo 3-4x).

**Costo per clinica:** | | EBITDA | Prezzo (3-4x) | Cash al closing (~65%) | |---|---|---|---| | Piccola (~€0,8M ricavi) | ~€160k | €0,5-0,65M | ~€0,35-0,45M | | **Tipo (~€1,2M ricavi)** | ~€240k | ~€0,84M (3,5x) | ~€0,55M | | Mid-size (~€2M ricavi) | ~€400-500k | €1,4-2M | ~€0,9-1,3M |

Il **cash al closing** è ~60-70% del prezzo: il resto è **rollover equity** (venditore reinveste, zero cassa) + **earn-out differito** (24 mesi, dai risultati). Più **capex format ~€100-200k/clinica**.

**Cassa da raccogliere per le prime 2-4 (clinica-tipo ~€1M EV):** | Voce | 2 cliniche | 3 cliniche | 4 cliniche | |---|---|---|---| | Cash acquisizioni (65%) | €1,3M | €1,95M | €2,6M | | Capex format (~€150k/cl) | €0,3M | €0,45M | €0,6M | | Piattaforma / team / WC / riserva | ~€0,6M | ~€0,7M | ~€0,9M | | **Cassa da raccogliere** | ~€2,2M | ~€3,1M | ~€4,1M |

→ ~€2,5-4,5M = la Fase 1 da 4-5M del deck. Note: (a) **paghi sull'EBITDA verificato** (dichiarato/normalizzato), spesso meno del reale gonfiato dal nero → a tuo favore; (b) per le prime 2-4 assumi **quasi tutto equity** (banche prestano poco senza track record); la **leva arriva in Fase 2** e riduce l'equity per clinica — è così che i 12M totali fanno 6-8+ cliniche.

**Chi mette il capitale: founder, debito o investitori?**

Le prime cliniche si comprano con il **capitale degli investitori** (raccolta Fase 1, equity), **non** con soldi dei founder e **non** con debito.

| Fonte                                         | Cosa finanzia                                       | Quando        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Bridge founder (~€100-300k, quasi tutto Luca) | Setup NewCo, advisor, pilot, runway pre-raccolta    | Set-Q4'26     |
| Raccolta investitori 4-5M (equity)            | Prime 2-4 cliniche + piattaforma                    | Q4'26-2027    |
| Co-invest Luca 0,5-2M (opzionale)             | Skin-in-the-game + equity extra al prezzo del round | Al round      |
| Debito bancario                               | Acquisizioni successive (riduce equity/clinica)     | Fase 2 (2028) |

**Apporto founder in concreto:** ≈ zero cash necessario per comprare le cliniche (lo fa la raccolta) — l'apporto è **equity/sweat + ruoli**. L'unico esborso *necessario* è il **bridge pre-raccolta (~100-300k, Luca)**. Il **co-invest di Luca (0,5-2M dal ricavato Skylabs)** è **opzionale ma raccomandato** (commitment + equity extra + può ancorare il round); Diana/Marcello/COO **nessun cash**. Nessuno si indebita o garantisce personalmente: compra la NewCo. Il **debito** entra solo in Fase 2 (a track record): è la leva per cui i 12M totali fanno 6-8+ cliniche.

**Diritto di co-invest al prezzo del primo round entro il 31/12/27.** Poiché la tua liquidità Skylabs arriva a H2'27, puoi negoziare col lead anchor il diritto di **co-investire alla valutazione del primo round fino al 31/12/27**. Preferisci la forma **impegno con funding differito** (ti impegni ora, finanzia entro la data → gli investitori lo amano, skin-in-the-game garantito) alla **opzione libera** (facoltà, non obbligo → osteggiata: eserciti solo se va bene, li diluisci a sconto). Paletti: **nel term sheet e concordato, capped** (non illimitato), e **non rompe il 9:1** (compra quote investor-side, separate dall'equity founder). Nota: a fine 2027 la società potrebbe essersi ri-valutata (format provato) → l'anchor potrebbe chiedere finestra più corta o piccolo premio oltre una certa data; un flat capped fino al 31/12/27 è difendibile come allineamento founder.

**A che valutazione il primo round (4-5M)**

Il deck propone la Fase 1 **alla stessa valorizzazione del round pieno** (post-money €20M → 4-5M per ~20-25%). È founder-favorable ma **una richiesta alta pre-prova** (nessuna clinica ancora, format non provato, tu nuovo del settore): è la fase più rischiosa, e di norma la fase più rischiosa prende la valutazione **più bassa**, non la stessa.

**Raccomandazione — prezza la Fase 1 al suo rischio:** - **Opzione A — priced round realistico: €14-18M post-money** (4-5M → ~25-33%), con lo **stack di credibilità** (tu + Cammalleri + advisor Hippocrates) e la **struttura di de-risking** (tranche a milestone, governance, format pilot). Spingi verso €18-20M **solo** con un anchor forte che valida + un primo segnale di format. - **Opzione B — stagela (preferita): primo assegno più piccolo (€2-3M a €8-12M post)** per provare format + prima clinica, poi il resto a **step-up (€20M+) sulla prova**. Match prezzo ↔ rischio, meno diluizione precoce. - **Opzione C — convertibile/SAFE con cap+sconto** (cap ~€14-18M, sconto 15-20%): **rimanda la valutazione** al round priced della Fase 2 quando avrai la prova. Veloce, niente braccio di ferro sul numero ora.

**Avvertenze:** il numero lo fissa il **lead anchor** (price discovery) — serve prima l'anchor, poi il prezzo; e **4-5M è tanto per un seed**: prenderlo tutto a valutazione bassa ti **sovra-diluisce al momento più rischioso** → altra ragione per B/C. Il **€20M del deck è la Fase 2** (post-prova), non i primi soldi.

## Cap table Venere — ripartizione tra i founder

**Vista 1 — Founder al 100%, PRE aumento di capitale investitori** (quella che negozi ora coi co-founder):

| Founder                                                                                       | % (pre-aucap) | Razionale                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luca</b> — CEO, ideatore, capitale, M&A, IR + co-invest cash                               | <b>59,4%</b>  | è la tua iniziativa: guidi, raccogli, co-investi                                                                |
| <b>Diana (Salvo)</b> — #2 provato, owner del moat <b>AI/dati</b> (motore primario), full-time | <b>22%</b>    | il moat è front-loaded (Fase 1-2) ed è la ragione per cui il roll-up è vostro; parte alta legata a milestone AI |
| <b>COO / AD operativo</b> — full-time                                                         | <b>12%</b>    | esecuzione format e P&L per sede                                                                                |
| <b>Marcello (Cammalleri)</b> — clinical partner <b>part-time</b> (mantiene la pratica)        | <b>6,6%</b>   | credibilità + origination + protocolli + medici; comp dalla clinica; <b>1/9 di Luca</b>                         |
| <b>Totale founder</b>                                                                         | <b>100%</b>   | prima di investitori e pool                                                                                     |

**Regola vincolante (founders' agreement): il rapporto Luca:Marcello resta 9:1 a ogni stadio.** Marcello è ancorato a **1/9 di Luca**; Diana + COO + pool + investitori diluiscono i due **pro-rata**, preservando il 90:10 di fondazione. Diana alzato da 18 a 22 (AI/dati = motore primario già in Fase 1-2): i punti extra escono da **Luca**, non da Marcello. Lever clinico: fondando **85/15** il rapporto ancorato diventa ~5,7:1 e Marcello ~**10%**.

**Vista 2 — Post aumento di capitale** (raise €12M per il 60%, pool creato al round): investitori **60%**; la tua 59,4% pre si diluisce a ~**16,3%**, Diana ~**6%**, COO ~**3,3%**, Marcello ~**1,8%** (sempre 9:1 con Luca), con **option pool** ~**12-13%** per gli hire futuri.

**Leve:** il **ratchet** può portare i founder verso **45-50%+** a un buon exit (è lì la tua upside); il **cash co-invest** aumenta la tua % (quote investor-side comprate a €20M); **reverse vesting** su tutti; le **sedi di Cammalleri**, se confluiscono, valutate separatamente (related-party), non gonfiando la sua %; per un **COO** top usa il **pool**, non i founder.

## Sequenza di ingresso dei founder (fondazione snella, ingressi successivi)

Ha senso **fondare Venere solo con te e Cammalleri** e far entrare **COO e Diana dopo**, quando l'azienda è concreta. È elegante perché allinea tre cose: **concretezza** (entrano su una società reale, non su slide), **riservatezza** (Diana non è un socio Venere visibile durante la vendita di Skylabs → nessun paper trail sul suo move) e **timing del valore** (ognuno entra quando serve).

**La sequenza:** 1. **Fondazione — Luca 90% / Marcello 10%**. Marcello è l'unico indispensabile all'inizio (credibilità clinica + deal flow per la prima acquisizione), come **clinical partner part-time** (vedi sotto). 2. **COO — intorno alla prima acquisizione:** serve a far girare format e P&L; probabilmente **prima** di Diana. 3. **Diana — al closing di Skylabs (≈H2'27), sincronizzato con la PRIMA acquisizione.** Diana dev'essere dentro **dalla prima clinica del gruppo** per strutturarla **AI-driven dal giorno zero** (data model, outcome capture, gestionale proprietario) — non bolted-on. Poiché è visibile solo post-closing (riservatezza), **si temporizza il closing della prima acquisizione perché coincida col suo ingresso:** pre-closing fai pilot + raccolta + pipeline (LOI/DD), ma la prima acquisizione **chiude con Diana già dentro**. Lever: accelerando la vendita Skylabs a **H1'27** anticipi entrambi. *Da subito, però, imposta l'architettura dati come principio fondativo (specifiche data model + gestionale interim Diana-ready), così lui industrializza senza retrofit.*

**Perché i numeri tornano (e il rapporto si mantiene):** ratio Luca:Marcello = 90:10; emettendo poi **Diana 22%** e **COO 12%** con diluizione **pro-rata**, i due scendono a **59,4% / 6,6%** (base founder) — la Vista 1 — **restando 9:1**. Il 90/10 è ancorato: Marcello = 1/9 di Luca a ogni round.

**Presidio da mettere subito — founders' agreement alla fondazione:** pre-definisce (a) la cap table target fully-diluted, (b) le **quote riservate e il vesting per Diana e il COO** (emesse al loro ingresso), (c) l'**option pool** (con una riserva per la futura leadership clinica), (d) **reverse vesting** su tutti, e (e) i **deliverable clinici di Marcello** cui è legato il suo vesting. Così ognuno sa la propria traiettoria e nessuno rinegozia dopo.

## Il ruolo di Marcello: clinical partner part-time (mantiene la pratica)

Struttura raccomandata: **Marcello porta due cappelli** — (a) **1 giorno/settimana sulla parte societaria** (clinical partner), e (b) **medico praticante nelle cliniche del gruppo**, a partire dal **flagship** (dove guadagna i suoi ~€240k). Entra con l'**equity come unico upside** (stipendio da società minimo/nulla). Fondazione **90/10** (Luca 90 / Marcello 10). Il punto vero: **il suo impegno societario dev'essere scritto e misurato**, o un part-time con equity "non fa nulla e aspetta l'exit".

**In cosa il suo tempo è fondamentale — le 5 aree non delegabili:** 1. **Origination + due diligence clinica dei target.** Conosce il settore: quali studi valgono, quali medici sono credibili, i **volumi reali** di procedure (vs libri gonfiati), chi vende ed è motivato. È il "network clinico" che il deck indica come fonte n°1 di deal flow. Un finanziario non sa giudicare se i ricavi di una clinica sono clinicamente sostenibili — lui sì. 2. **Format e protocolli clinici.** Disegna i percorsi di cura, il mix clinico (iniettabili, energy-based, rigenerativa, post-GLP-1) e la meccanica del **recurring su prescrizione** — che è medica e deontologica, non commerciale. 3. **Reclutamento e retention dei medici.** Attrae e valuta i medici per il modello multi-provider, ed è il **pari** che rispettano: i medici restano per un leader clinico credibile, non per una holding. Mitiga il rischio n°1 "dipendenza dal medico". 4. **Volto clinico verso investitori e venditori.** In raccolta (family office) e in trattativa: un medico vende più volentieri a una piattaforma guidata da un collega rispettato. Chiude il tuo gap di credibilità di settore. 5. **Qualità clinica, governance e reputazione.** Sotto il comitato scientifico indipendente, è il leader clinico esecutivo responsabile di protocolli, outcome tracking e presidi reputazionali — **il rischio n°1 che distrugge brand e multiplo.**

**L'impegno concreto (per evitare che non faccia nulla) — da scrivere nel founders' agreement:** - **Tempo minimo (parte societaria): 1 giorno/settimana garantito** (sourcing/DD clinica, protocolli, reclutamento medici, governance) — compatibile con la pratica. - **Deliverable/KPI trimestrali:** n° di target qualificati sourced+vettati, protocolli consegnati, medici reclutati; **presenza obbligatoria** ai meeting di fundraising e alle review di qualità clinica. - **Vesting legato ai deliverable, non solo al tempo**, con **clausola di underperformance/bad-leaver**: se coasta, l'equity non maturata torna indietro. È questo che rende l'impegno reale. - **Comp:** €0-minimo dalla società per il ruolo corporate; guadagna dalla **pratica clinica nel flagship del gruppo** (comp a **valore di mercato, arm's length, related-party documentato**); l'equity è l'upside e vesta sui risultati.

**La quota (90/10):** a regime, dopo l'ingresso di **Diana 22%** e **COO 12%** (diluizione pro-rata), il 90/10 atterra su **Luca 59,4%** / **Marcello 6,6%** — **rapporto 9:1 preservato** (Marcello = 1/9 di Luca). Se lo vuoi più vicino a ~**10-11%**, fondi **85/15**. L'equity non assegnata a un co-founder clinico pieno resta a **Luca** e/o va **riservata nel pool** per la futura leadership clinica (un **CMO full-time** quando scali, i direttori sanitari, il KOL advisor).

## Il flagship come "format lab" (con Marcello)

Idea forte: **lanciare la prima clinica brandizzata con Marcello come medico di riferimento**, per **testare e codificare il format** in un ambiente che controlli al 100%, poi replicarlo. Vantaggi: - **Prova del formato pulita:** dimostri i KPI (recurring, uplift EBITDA/clinica) in una sede tua, senza le abitudini legacy di una clinica acquisita. - **Credibilità istantanea:** Marcello come anchor doctor + **showcase** per investitori e per i medici-venditori ("guarda cosa fa il format"). - **Comp di Marcello risolta:** pratica nel flagship → guadagna lì i suoi ~€240k (market-rate, related-party), **zero cash-burn** per la società. - **Il pilota parte senza Diana** (gira su Marcello + COO + te); ma **la prima acquisizione chiude con Diana dentro** (sincronizzata col closing Skylabs) → clinica #1 AI-driven dal giorno zero. L'architettura dati va però impostata subito, Diana-ready.

**Ma tienilo nel ruolo giusto: il flagship è un laboratorio, non il motore di scala.** Lo **scale** resta **buy-and-build** (acquisisci cliniche profittevoli a 3-4x e le **converti** al format — è la tesi del deck, l'arbitraggio di multipli); il greenfield puro sarebbe più lento e rischioso. Quindi: **1 flagship per perfezionare e mostrare il format** → poi **acquisisci-e-converti a scala**. Usa Marcello come **template clinico e formatore** per replicare lo standard nelle sedi successive.

**Come tenerlo snello — 7 regole:** 1. **Affitta uno spazio + porta dentro i pazienti di Marcello (NON comprare l'immobile, NON greenfield puro).** Marcello non ha una clinica di proprietà convertibile in una città strategica (Gela è co-owned coi fratelli e fuori mercato; Milano/Verona sono studi affittati part-time). La via snella è la **terza: affitta** uno spazio dedicato a **Milano** (piccolo, espandibile), brandizzalo con fit-out leggero, e **fai confluire lì la sua pratica part-time Milano+Verona** → **location greenfield ma domanda non-greenfield** (testi il recurring su pazienti reali dal giorno 1). Marcello riceve lì e ci guadagna i suoi ~€240k (market-rate, ⚠ related-party documentato). **Non comprare l'immobile:** il capitale di Fase 1 è per format + acquisizioni, non per il mattone; semmai una **propco/sale-leaseback separata** più avanti. **Una sola sede** (Gela fuori). 2. **Capex minimo e in fasi:** affitto non acquisto; parti dagli **iniettabili** (basso capex), aggiungi i **dispositivi energy-based** (parte cara) **solo dopo** aver provato il recurring. Sede credibile, non un monumento. 3. **Time-box 6-9 mesi:** l'obiettivo non è fatturato, è



**codificare il format e centrare i KPI** (recurring %, uplift EBITDA/clinica, conversione, retention). Poi sposti il focus sulle acquisizioni. 4. **Strumentata, non ingioiellare**: produce **dati + playbook replicabile**, non è un profit center. **Gestionale interim off-the-shelf** (quello di Diana viene dopo), protocolli standard, fornitori esistenti. Zero bespoke pre-prova. 5. **Team leggero**: Marcello (1 g/sett + pratica) + **un site manager** + supervisione COO. Serve a *disegnare* i ruoli da replicare, non a staffare un team centrale attorno a una clinica. 6. **Una sola, non una mini-catena**. Uno basta per provare e codificare; la moltiplicazione viene dalle acquisizioni. 7. **Ring-fence capitale e attenzione**: cap esplicito e piccolo sul capitale al flagship (fetta minima dei 4-5M); **il focus tuo e del COO resta la pipeline di acquisizione**. Criterio d'uscita dal "lab": format codificato + KPI centrati + playbook + showcase pronti → da lì è la **clinica #1 della rete**, non più un progetto speciale.

**Cosa c'è davvero da testare (e se serve un flagship)**

Domanda chiave: cosa si testa che Marcello non fa già da solo? **Non l'atto clinico** (quello lo sa fare) — ma il **format**, il layer di piattaforma che un mono-medico non fa: - **Parte "domanda"** (recurring su prescrizione, patient journey retail con beauty advisor + recall, pagamenti rateali, cross-sell del mix, KPI): **testabile a costo quasi zero innestandolo sui pazienti che Marcello ha già**, anche negli studi attuali. **Non richiede un flagship dedicato**. - **Parte "scala"** (multi-provider / **depersonalizzazione** — paziente fedele al brand non al medico —, area management, procurement a volume): **non provabile con Marcello** (i suoi pazienti sono fedeli a lui, ed è l'unico medico) → si prova solo sulla **prima clinica acquisita e convertita**. - **La matematica della tesi** (+45% ricavi, margine 20% → 27% per clinica): la dimostri meglio su una clinica acquisita convertita che su un pilota costruito attorno a Marcello.

**Quindi il flagship in affitto dedicato si giustifica SOLO se vuoi**: (i) uno **showcase** brandizzato per investitori/venditori, e (ii) triare il **multi-provider in ambiente controllato prima** di comprare. Altrimenti la via più snella è: **parte "domanda" innestata sui pazienti di Marcello nell'esistente + parte "scala" provata sulla prima acquisizione** — risparmiando capex e attenzione. Decidi il flagship in base a *queste due domande*, non per "provare il format" in generale.

**Advisory board Venere — short list**

Costruisci un advisory board mirato che **chiude il tuo gap di credibilità di settore** e porta know-how esecutivo. Formalizzato (lettere d'incarico + NDA), con **equity/warrant dal pool** (non dai founder) e ruoli non sovrapposti.

| Advisor                                                                                | Cosa porta                                                                                                                              | Aggancio                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Fondatori Hippocrates Holding (La Farmacia)</b>                                     | Buy-and-build healthcare-retail regolato in ITA (farmacie): consolidamento multi-sede, raccolta PE, exit, credibilità coi family office | Advisory con equity/warrant ⚠ NDA (consolidatore adiacente)     |
| <b>Ex-operatore catena medspa US/UK</b> (profili tipo LaserAway, sk:n, Harley Medical) | Il format che Venere replica: recurring su prescrizione, patient journey retail, multi-provider, unit economics                         | Advisory internazionale                                         |
| <b>KOL clinico di medicina estetica</b> (oltre Cammalleri)                             | Autorevolezza clinica, protocolli, reclutamento medici                                                                                  | <b>Presiede il comitato scientifico indipendente</b> (dal deck) |
| <b>Advisor regolatorio-sanitario</b>                                                   | Autorizzazioni regionali, pubblicità sanitaria/deontologia, struttura MSO, GDPR sanitario                                               | Advisor dedicato dal giorno uno (dal deck)                      |
| <b>Advisor M&amp;A healthcare + fiscale-M&amp;A</b>                                    | Origination, DD con normalizzazione ricavi, earn-out/rollover, fiscalità                                                                | Deal team (dal deck)                                            |
| <b>Consigliere indipendente in board</b>                                               | Contrappeso di governance                                                                                                               | Board seat (dal deck)                                           |

Cautela trasversale: per gli advisor che operano in **consolidamento adiacente** (Hippocrates), selettività su cosa condividi del **vantaggio proprietario** (gestionale/dataset).

**Partnership procurement con La Farmacia (Hippocrates tra i soci)**: ha senso, soprattutto perché ti dà **scala d'acquisto in prestito da subito** (in Fase 1, quando da solo non hai volume) + **logistica/supply affidabile**. Aiuta di più su **consumabili, skincare, generici**; meno sugli **iniettabili branded** (tossine/filler), dove il prezzo lo fanno i **produttori** (AbbVie/Allergan, Galderma, Merz) con deal diretti a volume — la farmacia è secondaria lì. Attenzioni: **related-party** (arm's length, a mercato,



documentato), **canale regolatorio** (tossina = farmaco su prescrizione, verifica l'approvvigionamento) e non creare **dipendenza** da un consolidatore adiacente.

---

## Avviare Venere — i primi 6 mesi, passo per passo

**Mese 1 (settembre) — Fondamenta legali e societarie** 1. **Founders' agreement** Luca/Marcello (90/10, vesting, deliverable di Marcello, slot riservati Diana + COO + pool). 2. **Costituzione NewCo con architettura MSO**: una **holding di gestione** separata dalle **società mediche operative** (l'atto medico sotto direttore sanitario/struttura autorizzata). Giusta per il regolatorio e per il tema fiscale (sotto). 3. **Ingaggia gli advisor**: fiscalista/M&A, avvocato sanitario-regolatorio, notaio, commercialista. 4. **Gestionale interim** off-the-shelf + accounting + CRM. 5. **One-pager Fase 1 + data room** per la raccolta.

**Mese 2-3 (ott-nov) — Clinico, capitale, pipeline (in parallelo)** 6. **Marcello**: protocolli clinici + disegno dei **percorsi di cura ricorrenti**; insedia comitato scientifico e individua il direttore sanitario. 7. **Format pilot "domanda"**: innesta recurring + beauty advisor + recall + rateizzazione + KPI **sui pazienti esistenti di Marcello** e misura. 8. **Raccolta Fase 1 (4-5M)**: brief lead anchor family office + angel di settore + **advisor Hippocrates** → soft-circle. 9. **Pipeline M&A**: 1 cluster, criteri target del deck, lista 8-12, **LOI su 2-4**.

**Mese 4-6 (dic-feb) — Chiudere e partire** 10. **Assumi il COO**. 11. **Closing Fase 1** (4-5M). 12. **LOI + due diligence** sulle prime cliniche (con normalizzazione ricavi → nodo nero sotto). *Il closing della prima acquisizione si sincronizza con l'ingresso di Diana (~closing Skylabs, H2'27) per strutturarla AI-driven da subito; accelerando Skylabs a H1'27 lo anticipi*. 13. **Playbook integrazione a 100 giorni** pronto.

*(Diana entra al closing di Skylabs, ~H2'27 — riservato fino ad allora.)*

---

## Come individuare e acquisire in fretta le prime cliniche

### A. Individuarle (origination + screening)

**Canali di sourcing, in ordine di potenza**: 1. **Il network clinico di Marcello** — il canale n°1: sa quali studi valgono, quali medici sono credibili, chi è vicino alla pensione, i volumi reali. Congressi e associazioni (AITEB, SIME, AICPE). 2. **I fornitori di iniettabili e device** (AbbVie/Allergan, Galderma, Merz; laser/energy: Candela, Cynosure, DEKA/El.En.) — **il canale killer**: conoscono i **volumi reali** di ogni studio (vedono gli ordini) → originano deal e triangolano dichiarato vs reale (arma contro il nero). 3. **Advisor di settore (fondatori Hippocrates) + M&A/commercialisti locali** nella regione target. 4. **Outreach diretto** proprietario agli studi che rientrano nel profilo — non da broker (il miglior deal flow non passa dalle aste).

**Screening — come scegliere**: - **Cluster-first**: una sola regione (NO o NE), in profondità per densità (GM condiviso, procurement, marketing). Non disperdere. - **Qualità della clinica**: base pazienti reale + iniettabili ripetibili (recurring-amenable), 2+ medici o convertibile, bacino 100k+, autorizzazioni pulite. - **Qualità del venditore**: motivato (uscita generazionale), disposto a **permanenza 24-36 mesi + rollover**, allineato, zero baggage reputazionale. La disponibilità a rollare equity è il segnale più forte. - **Verificabilità dei numeri** (POS/banca/acquisti dai fornitori) e **convertibilità al format** + headroom (saturazione agende). - **La "clinica-ancora"**: la prima sia forte e credibile → hub del cluster + showcase.

### B. Acquisirle in fretta

La velocità non è chiudere UN deal in fretta: è avere **2-4 deal già pronti** (sourcing + LOI + DD fatti pre-closing) da chiudere in una **finestra compressa** appena Diana entra (~H2'27). 1. **Front-load pipeline e DD (2026-H1'27)** in parallelo a pilot e raccolta → a Diana entrato **esegui, non inizi**. 2. **Deal template + playbook standard** (3-4x, 60-70% cash, earn-out, rollover, non-compete + checklist SPA/DD ripetibile): ogni deal è un "riempi il modello", non bespoke. 3. **Deal bilaterali proprietari (non aste)**: venditori motivati dal network di Marcello + intro dei fornitori → warm, veloci, economici. 4. **Prime target semplici** (proprietario singolo, autorizzazioni pulite, numeri verificabili) → chiudi in fretta e costruisci il playbook; i complessi dopo. 5. **Rollover + earn-out riducono cassa e attrito**: il venditore resta e rolla equity → allineato, colma il gap di valutazione senza braccio di ferro. 6. **Deal team + advisor dal giorno 1** (M&A, avvocato sanitario, fiscalista) + **pre-work regolatorio** (autorizzazioni/trasferimento, continuità del direttore sanitario — spesso lo step lento: scopilo presto).

---

## Come contattarli senza spaventarli (playbook di approccio)

Con un medico **non hai una seconda prima impressione**: un contatto freddo sbagliato brucia il target. Regola: **né visita a sorpresa, né email a freddo** → **intro calda + incontro informale tra pari**.

**Ordine di efficacia**: (1) **intro calda** dal network di Marcello (medico-a-medico), da un **fornitore** (i rep conoscono tutti), o da un contatto comune; (2) se non c'è intro, contatto **personale e discreto** (messaggio/telefonata da te o Marcello, non email aziendale) che chiede *"uno scambio sul futuro del settore"*, zero ask di acquisto; (3) **mai** email aziendale a freddo, contatto via **reception/centralino**, broker a freddo, mass-mailing.

**La sequenza**: 1. **Lista + intel** (chi rientra nei criteri + segnali di apertura). 2. **Trova la via calda** per ognuno (Marcello / fornitore / contatto comune). 3. **Primo incontro informale off-site** (caffè/cena), inquadrato come **scambio tra pari, non pitch**. Apre **Marcello**, entri tu con la visione. 4. **Ascolta l'80%**: capisci la **motivazione** (pensione? admin? crescita?). Nessun numero sul tavolo. Costruisci fiducia. 5. **Se fit reciproco** → **NDA** → seller pitch → termini indicativi. 6. **Coltiva i non-pronti** (convertono in 12-24 mesi): è una pipeline da nutrire.

**Riservatezza sacra**: contatti il medico **personalmente e in privato**, mai tramite lo studio — la sua paura n°1 è che staff/pazienti/concorrenti scoprano che potrebbe vendere. Il rischio non è "contattare presto", è **contattare freddo e male**.

---

## La storia da raccontare ai medici (seller pitch)

Narrazione lato venditore: **trasforma i suoi dolori in ragioni per entrare, senza toccare la sua medicina**.

**Arco (una riga)**: *"Hai costruito uno studio che vale, ma da solo hai toccato il suo soffitto: non scala, ti tiene inchiodato (lo studio SEI tu), paghi metà in tasse o rischi col nero, e non ha vero valore di rivendita né successione. Noi togliamo il soffitto e ti de-riskiamo — senza toccare la tua medicina."*

**I 5 messaggi (dolore → soluzione)**: 1. **Ricchezza che da solo non avrai mai**: cassa al closing + equity nella piattaforma (7-10x) = un **secondo payday più grande all'exit**. Il tuo studio da solo non ha exit. 2. **Reddito** → **capital gain**: smetti di perdere ~50% in tasse / rischiare col nero; l'equity è tassata ~26%. Legale ed efficiente. 3. **Togliamo il soffitto**: brand, marketing, recurring, rateizzazione = **più pazienti** e ticket più alti; procurement/back office/software/HR li gestiamo noi. **Più medicina, meno burocrazia** — il lordo cresce anche diventando bianco. 4. **Tieni medicina e autonomia**: la piattaforma **non interferisce sull'atto clinico**; comitato scientifico indipendente; **incentivi mai sui volumi** (nessuno ti spinge a sovra-trattare). (*Disinnesca la paura n°1: la corporatizzazione.*) 5. **De-risk e successione**: non sei più l'unico punto di rottura; multi-provider = lo studio sopravvive oltre te; uscita dignitosa **con valore**, non uno studio che muore con la pensione.

**Leva del timing**: i **primi** prendono le condizioni migliori e la fetta più grande — prima che la piattaforma sia costruita e de-riskata. **Meglio founder-doctor che late joiner**.

**Fletti sul profilo**: pensione → successione+liquidità; giovane ambizioso → crescita+equity+leadership; stressato da burocrazia/nero → togliamo l'hassle e regolarizzi conveniente.

**Cosa NON dire**: non promettere di preservare il nero; non aprire con "venderai più trattamenti"; non presentarti come "un fondo che ti compra" ma come "costruiamo insieme la piattaforma che il settore non ha — con medici, non burocrati". **Marcello + comitato scientifico** rendono il tutto credibile: entra in una comunità clinica guidata da pari, non vende a un fondo anonimo.

---

## La struttura dell'offerta al venditore (cash / rollover / earn-out)

Il prezzo lo àncori a **3-4x l'EBITDA normalizzato** (documentato/normalizzabile — **non** il nero). Su quel totale, lo split che consiglio:

| Componente                | Quota   | Quando si incassa             | Funzione                                |
|---------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Cash al closing           | ~60%    | subito                        | liquidità certa, il "sì"                |
| Rollover equity in Venere | ~20-25% | all'exit di gruppo (7-10x)    | il "secondo payday" + allineamento      |
| Earn-out / differito      | ~15-20% | in tranche su <b>2-3 anni</b> | retention + colma il gap di valutazione |

**In una riga:** ~60% subito, ~40% dopo — di cui **metà congelata** nella piattaforma fino all'exit di gruppo (rollover) e **metà come earn-out** su 2-3 anni.

**Earn-out — dopo quanti anni: 3 anni** dove il medico è l'asset (serve tempo per far transitare i pazienti e depersonalizzare col multi-provider), **2 anni** dove la dipendenza dal titolare è minore. Tranche annuali legate a **(a)** mantenimento/crescita EBITDA e **(b)** permanenza (good leaver). Cammina insieme alla permanenza 24-36 mesi.

**La leva sul nero (risolve due problemi in uno):** cash e base li paghi **solo sull'EBITDA documentato**; il valore del sommerso NON lo paghi in contanti (non è verificabile né riconoscibile legalmente) ma lo lasci **recuperare al venditore via earn-out agganciato all'EBITDA formalizzato** (POS, financing, fatturazione piena). Il medico guadagna il valore del nero **sbiancandolo**, tu paghi solo su numeri reali e tracciati. Il problema diventa il meccanismo di allineamento. *(Si combina con il "periodo pulito" pre-acquisizione — sotto.)*

**Paletti standard: reverse vesting** sul rollover (bad leaver decade), **non-compete**, **holdback ~10%** per 12-18 mesi a garanzia (reps & warranties).

**Esempio** — EBITDA normalizzato €400k × 4x = **€2,0M**: cash al closing **~€1,2M**, rollover in Venere **~€0,45M** (allo stesso prezzo del round), earn-out **~€0,35M** su 3 anni su EBITDA formalizzato + permanenza.

**Come flettere lo split sul profilo del venditore:** - **Pensione/uscita:** più cash subito (fino a ~70%), rollover minore — vuole liquidità, non una seconda scommessa. - **Giovane/ambizioso:** più rollover (fino a ~35%) e ruolo — vuole il secondo payday e la crescita. - **Molto "in nero":** base cash contenuta + **earn-out più pesante** sull'EBITDA formalizzato — è lì che si gioca il suo upside.

## Il nodo del "nero" dei medici estetici (come affrontarlo, legalmente)

Gran parte dei medici estetici incassa in nero per non pagare ~50% di tasse. Ti crea due problemi: (a) **l'EBITDA dichiarato dei target sottostima il reale** → prezzi bassi ma venditori che pretendono credito per numeri non verificabili; (b) dentro una piattaforma fatturata il ricavo dev'essere **bianco**, e la conversione può comprimere i margini.

**Regola d'oro: non paghi per il nero e non lo perpetui. Lo sostituisci con più bianco.** Le 6 mosse: 1. **DD sul dichiarato/tracciabile:** normalizzi sui ricavi **fatturati/POS/banca; non paghi il cash non verificabile** (è frode, non bookabile). Prezzi su numeri puliti → entri basso, a tuo favore. 2. **Rischio fiscale pre-closing sul venditore:** rep & warranties + indennizzi + escrow nell'SPA. Non erediti la frode. 3. **Sostituisci il nero con più bianco via il format:** recurring a pagamento mensile + **rateizzazione + carte = pagamenti tracciabili per costruzione**; il +45% del format nasce bianco. Non preservi il nero, lo rimpiazzhi con un flusso bianco più grande. 4. **Rendi il bianco conveniente col rollover in EQUITY:** il medico converte reddito da lavoro (~50%) in **capital gain all'exit** (tassazione molto più bassa). È la leva legale più forte per farlo uscire dal nero: gli dai un **asset che vale a multiplo**, cosa che il nero non può dargli. 5. **Più volume dal sistema:** brand + marketing + recurring portano più pazienti → il lordo bianco su un book più grande eguaglia/supera il vecchio netto grigio. 6. **Compliance nativa = valore:** MSO, fatturazione, POS ovunque, incentivi mai sui volumi, audit (dal deck). Asset pulito e bancabile all'exit = **7-10x** vs 3-4x di studi grigi. **La regolarizzazione È l'espansione del multiplo — ed è il moat** (i grigi non possono farlo).

**Due avvertenze:** (a) metti in conto un **attrito di conversione** (qualche paziente cash resiste alla fattura) → modella conservativo, l'uplift deve superarlo; (b) è il **rischio d'esecuzione n°1** → serve un **fiscalista + avvocato sanitario top** (questo è framing, non parere fiscale).

**Il punto strategico:** il nero non è solo un ostacolo, è **la ragione per cui i medici hanno bisogno di te** — sono incastrati (non scalano, non accedono a capitale, non vendono a istituzionali). Tu offri equity capital-gain-efficient + più pazienti + un exit pulito.

## Il "periodo pulito" pre-acquisizione (tecnica di DD)

Chiedere al venditore di **andare bianco 6-12 mesi prima di comprare**, osservare l'EBITDA dichiarato sotto piena fatturazione e annualizzare. Dà una **base verificabile e legale** su cui prezzare, testa direttamente il **drenaggio da sbiancamento** (quanti cash resistono alla fattura) e **filtra i venditori** (chi rifiuta è red flag: il suo "reale" è nero che evapora).

**Il nodo — l'incentivo:** da solo il venditore non ci sta (paga ~50% di tasse su un reddito per cui non è ancora pagato). Si risolve **firmando prima un accordo quadro vincolante col prezzo = multiplo sull'EBITDA bianco dimostrato**: *"dimostralo bianco e ti pago 3,5x su quello"* → il tempo bianco diventa ciò su cui incassa, non un costo secco.

**Robustezza:** 6-12 mesi (12 meglio per stagionalità); **triangola coi dati dei fornitori** (ordini iniettabili/device) anti-gaming; **introduci già gli strumenti white-friendly del format** (rateizzazione, recurring, carte) così vedi il **bianco assistito dal format**, più rappresentativo del post-acquisizione. Il periodo pulito è anche l'inizio della transizione.

**Alternativa più veloce:** prezzo sul **dichiarato storico + earn-out** sui risultati bianchi futuri → stesso risk-sharing senza aspettare. **Raccomandazione:** periodo pulito per le **prime cliniche** (hai tempo mentre aspetti Diana/closing Skylabs, costruisci il playbook); poi earn-out + triangolazione fornitori per la velocità.

## Cosa impariamo dall'estero (e come farne un'opportunità)

I precedenti utili: roll-up di **sanità/dentale in mercati con forte informalità** (Brasile, India) + **USA** per il recurring. - **Dentale Brasile / diagnostica-dentale India** (PE-backed → spesso IPO): la tesi era **professionalizzare + formalizzare** → **EBITDA auditabile** → **multiplo premium**. La pulizia è il re-rating. - **Brasile, pagamento a rate ("carnê")**: il financing ha **reso tracciabile il ricavo e allargato il mercato** (affordability mensile). È stato lo strumento di formalizzazione — esattamente la tua rateizzazione. - **USA medspa, membership**: il ricorrente formalizza (abbonamenti fatturati) e alza l'LTV. - **Rollover in equity** (standard US/EU): il cuneo fiscale (capital gain « reddito da lavoro) tira gli owner verso il bianco.

**Le 5 lezioni:** (1) **la formalizzazione È l'arbitraggio** — compri grigio a 3-4x, vendi pulito a 7-10x; l'informalità è la ragione per cui lo spread esiste; (2) **financing/recurring converte cash in bianco e allarga il mercato**; (3) **il cuneo fiscale è leva di reclutamento** (equity rollover); (4) **la compliance è brand di fiducia** verso i pazienti; (5) **cautela spagnola** (Vitaldent/Dentix, collassati): formalizza **senza iper-commercializzare** — governance clinica dominante, incentivi mai sui volumi.

**I 3 ribaltamenti problema → opportunità:** 1. **L'informalità = la tua opportunità di arbitraggio**. Il nero deprime i multipli d'ingresso: è ciò che ti fa comprare a poco. Senza informalità non ci sarebbe spread 3-4x → 7-10x. 2. **Il cuneo fiscale = la tua calamita per acquisire medici**. Gli offri di smettere di rischiare l'evasione e convertire il reddito in **capital gain + quota a multiplo + più pazienti**. Il problema che li opprime diventa il tuo argomento di vendita. 3. **La compliance = il tuo moat**. I grigi non scalano/non accedono a capitale/non vendono a istituzionali. Tu costruisci l'unico asset pulito, bancabile e a marchio — ciò che all'exit paga il PE.

---

## Il "data play" di Venere: dal roll-up al dataset per l'automazione (l'upside di lungo)

La ragione per cui **questo** team (tu + Diana, DNA AI) dovrebbe fare **questo** roll-up: non solo consolidare cliniche, ma **raccolgere il dataset proprietario** che nel tempo **riduce la dipendenza dal medico** — il costo e il rischio n°1 del settore.

**Il percorso, 3 livelli a orizzonti diversi:** 1. **Oggi — moat di qualità (già nel deck):** outcome standardizzati (before/after controllati, aderenza protocolli, risultati per sede/medico). **Costo marginale ~zero: è un byproduct del format**. Va **strumentato bene dalla clinica #1** (imaging standard, mappe di iniezione, parametri device, outcome 30/90/180, consensi + GDPR by design). Diana costruisce il gestionale (post-closing) con questa architettura-dati in testa. 2. **Medio — AI decision-support:** l'AI **suggerisce** piano/dosaggio/protocollo sul dataset reale del gruppo; standardizza la qualità e **riduce la dipendenza dal singolo medico** (mitiga il rischio n°1). *Il medico decide* — resta fuori dal perimetro dei dispositivi medici (paletto del deck). 3. **Lungo (7-15 anni) — automazione/robotica** di procedure standardizzate e image-guided (energy-based, laser, certi iniettabili sotto guida): il dataset è il **substrato di training**. Qui sostituisci progressivamente l'**ora-medico** con la macchina → attacchi il costo e il collo di bottiglia strutturale del settore.

**Perché conta anche se non arrivi ai robot:** - **Ri-valuta l'exit:** da multiplo *healthcare-services* (7-10x EBITDA) verso multiplo *med-tech/AI-platform* — molto più alto (è il ponte tra la §Appendice-monetizzazione e un upside superiore). - **Compratore premium naturale:** un dataset proprietario di outcome + decision-support lo pagano caro un **device-maker** (Galderma,

AbbVie/Allergan, produttori laser/energy) o un PE tech — anche senza automazione piena. - **È il tuo differenziatore unico:** nessun consolidatore finanziario puro può farlo. È il motivo per cui il roll-up dev'essere **tuo**, e la tua competenza AI (commodity in Skylabs) qui è **scarsa e decisiva**.

**I guardrail (per non sbagliare):** - **Non distrarti dal core:** i soldi si fanno nel roll-up (buy-and-build + formalizzazione + recurring). Il data play è **optionality**, non la base — Fase 1-3 devono inchiodare prima il roll-up "noioso". - **Regolatorio pesante** sull'automazione (MDR, responsabilità, "il medico decide"): arco lungo, non piano a breve. - **Focus oggi = basso** (strumenta solo la raccolta dati), **importanza strategica = alta** (alza l'exit e giustifica il team). Diventa un focus maggiore in **Fase 3+**, a scala di dati.

---

## Sfruttare il modello Bending Spoons (cosa copiare, cosa NON copiare)

Venere e Bending Spoons sono **la stessa architettura di creazione di valore applicata a settori opposti** — vale la pena rubarne il metodo con gli occhi aperti. BS non inventa prodotti: **compra asset digitali maturi** (Evernote, WeTransfer, Meetup, Brightcove...), li **aggancia a un'unica piattaforma operativa centrale** (crescita, monetizzazione, dati, tecnologia, finanza), li **ottimizza** e li tiene, componendo nel tempo. È buy-and-build con una macchina centrale e una testa tech. Esattamente la tesi di Venere.

**Le similitudini vere (da valorizzare):** - **Compri il provato, non il nuovo.** BS compra prodotti con utenti e ricavi reali; noi cliniche con pazienti ed EBITDA reali. In entrambi il rischio "prodotto/mercato" è già superato: il valore si crea nell'**operare meglio**, non nell'esistere. - **Una piattaforma, molti asset.** Il vero prodotto di BS è la macchina centrale; le app sono "nodi". Per Venere la macchina è il **format playbook + procurement + brand + gestionale/data layer + GM d'area**: le cliniche sono nodi. **Corollario operativo:** investi presto e pesante sulla macchina centrale (è ciò che scala), tieni **HQ snello ed elitario** (BS gestisce decine di prodotti con un team centrale piccolo e denso). - **La monetizzazione è una scienza, non un'intuizione.** L'edge n°1 di BS è l'ingegneria della monetizzazione (abbonamenti, pricing, retention per coorte, LTV). È **identico** ai nostri leve: percorsi ricorrenti, membership, financing, upsell, saturazione agende. Trattali come BS: **misura coorti, testa prezzi, ottimizza LTV** — non "a sensazione". - **Dati + tecnologia come leva di portafoglio.** Il "platform team" di BS gira su tutti gli asset. **Questo è esattamente il ruolo di Diana:** il data play (decision-support → automazione) è la nostra piattaforma tech cross-cliniche. Da raccontargli così — è la parte che rende il progetto "suo" e non un roll-up qualsiasi. - **Ottionalità da capitale paziente.** BS non ha un exit forzato: tiene e compone. Noi manteniamo la tesi del multiple arbitrage (exit 5-10 anni), ma **costruire così che "tenere e comporre" sia attraente quanto vendere** riduce la pressione e migliora il potere negoziale con investitori e venditori. - **Struttura di capitale.** BS finanzia le acquisizioni con **debito + cassa generata**. È il nostro schema di Fase 2-3 (roll-up a leva sui flussi delle cliniche integrate): il modello è già dentro il piano.

**Cosa NON copiare (il paletto che vale doppio in sanità):** - BS ha una **reputazione aggressiva** — tagli di personale, aumenti di prezzo, funzioni amate rimosse. In un business digitale l'utente incassa e resta; in **medicina il moat È la fiducia** (paziente, medico, deontologia). Prendiamo la **disciplina della piattaforma**, non l'etica dello spremere clienti e staff. - BS taglia costi su asset a **costo marginale ~zero**; noi abbiamo **atti medici regolati, lavoro clinico, responsabilità**: non si "licenzia il core". La depersonalizzazione è un obiettivo di sistema (multi-provider, protocolli), **non** un taglio di medici.

**Come usarlo, in pratica:** 1. **Framing per investitori e per Diana:** *"la Bending Spoons della medicina estetica"* — analogia italiana, riconoscibile, investibile: piattaforma centrale + dati + monetizzazione su asset provati. Usala nel pitch e nel colloquio con Salvo (senza gli aspetti reputazionali). 2. **Metti la macchina centrale al centro del budget** di Fase 1-2 (non è overhead: è il prodotto). 3. **Istituisce la "monetization science"** come funzione (coorti, pricing, LTV) fin dal format lab. 4. **Posiziona Diana come il "platform/data team"** cross-portafoglio, non come IT di supporto. 5. **Progetta l'ottionalità hold-or-sell** nella governance (patti che non ti costringano a vendere a scadenza).

## L'esperienza di Skylabs come motore di Venere (senza legare le due aziende)

La "macchina centrale" di Venere (il platform-team alla Bending Spoons) di fatto è un *operating system* interno AI-driven: agenti che gestiscono agende, recall, pricing, procurement, KPI, decision-support clinico. È naturale chiedersi se travasarci lo **Skylabs OS**. La linea è netta: **le due aziende restano separate — di Skylabs porti in Venere l'esperienza, non l'asset.**

- **Nessun legame tra le due società.** Niente riuso del codice/IP di Skylabs, niente accordo commerciale, niente Venere-come- vetrina di Skylabs. Stai **vendendo** Skylabs a uno strategico (Cegeka/Bip): quell'IP sarà del compratore, e ogni intreccio



riaccende il rischio già a tabella ("*Rivendica su IP del gestionale → separazione IP clean-room o licenza periziata*") e **complica/abbassa la vendita**. Skylabs e Venere non si toccano.

- **Ciò che si trasferisce è l'esperienza, e cammina con le persone.** Il valore vero non è il software — è il **know-how tuo + di Diana**: come si costruisce e si fa girare una piattaforma agentica in verticale, cosa funziona e cosa no, gli errori già pagati, il metodo. Quello è **legittimamente vostro** e non ha vincoli: lo riversate in Venere costruendo il suo OS **da zero e in pulito**.
- **Il punto AI-driven:** l'"OS" di Venere non è un gestionale con sopra un chatbot. È l'azienda **progettata attorno agli agenti**: HQ minimo perché la piattaforma fa il coordinamento che altrove richiede middle-management. È qui che il DNA AI (commodity in Skylabs) diventa **vantaggio scarso** in un settore che non lo sa fare — ed è esperienza, non codice, a darvi il vantaggio di partenza.

**Verdetto:** si a costruire un "Venere OS" al centro dell'azienda, **alimentato dall'esperienza Skylabs** — ma come sistema nuovo e indipendente. Le due aziende restano separate: nessun ponte tecnico o commerciale che possa intaccare la vendita di Skylabs.

### Fronte finanziario e fiscale (verifica con commercialista — non è consulenza fiscale)

- **Allocazione proventi Skylabs:** (a) co-invest CEO in Venere, (b) riserva personale, (c) eventuale quota Fase 1. Definisci le tre quote prima di incassare.
- **Fiscalità della cessione:** valuta la struttura più efficiente (es. cessione via holding personale / regime PEX) **prima** del signing.
- **Non mischiare i flussi:** capitale Skylabs e Venere tracciati e separati (regola related-party).

### Rischi trasversali e mitigazioni

| Rischio                                  | Mitigazione                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soci non allineati sulla vendita-insieme | Framing win-win + prezzo equo dal processo competitivo                                                                          |
| Rivendica su IP del gestionale           | Separazione IP (clean-room o licenza periziata) chiusa in Fase 1, per iscritto, prima di ogni sviluppo Venere                   |
| Skylabs si svaluta durante il processo   | Muoviti nel 2026-27 (picco M&A AI); processo rapido; non far trapelare il disimpegno prima del closing                          |
| Fase 1 Venere non si finanzia            | Non chiudere Skylabs finché Fase 1 non è soft-circled; gate in sequenza                                                         |
| Attenzione divisa                        | Tabella tempi vincolante; advisor + GM + panchina tengono Skylabs                                                               |
| Rischio reputazionale clinico (Venere)   | Governance del deck (comitato scientifico, incentivi non legati ai volumi, audit, KPI reputazionali) attiva dalla prima clinica |
| Lobra non chiude ("forse")               | Non ancorare panchina/prezzo al deal incerto: costruisci su Sidea + PP                                                          |

### I 3 documenti da avere pronti per settembre

1. **Deck per i soci** sulla vendita congiunta (tempi, processo, advisor) — **senza** menzionare l'arrangement Diana ↔ Venere (riservato fino al closing).
2. **Skylabs info memo** (per l'advisor M&A) — gran parte esiste nel Company Profile.
3. **Venere Fase 1 one-pager** (per gli anchor) — estratto dal deck.

### KPI di successo (misura a ~settembre 2027)

- ☐ Skylabs venduta a strategico, tutti e quattro incassati, closing fatto

- ☐ Separazione IP e related-party chiuse per iscritto
- ☐ Venere: team completo (incl. Diana + COO), Fase 1 finanziata, 2-4 cliniche closed e in integrazione
- ☐ Tu: full-time su Venere, fuori da Skylabs
- ☐ Prima evidenza di uplift EBITDA/clinica sul formato